SOMPO流介護
カスタムメイドケア実践を図る10の評価項目～
SOMPO流介護プロセス品質評価
操作ガイド

2025年6月03日

SOMPOケア株式会社

未来の介護推進部
IT企画部社内egaku開発課

© 2024 Sompo Japan Insurance Inc. All Rights Reserved.

SOMPOケア

目次

1. Garoonの業務アプリ一覧からログインする方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
2. 【 ダッシュボード全体施設用 】の見方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
3. 【 ダッシュボード 全体 】の見方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

改訂履歴

日付	バージョンNo.	改訂ページ	改訂内容
2023年6月8日	v.1	初版	初版
2023年11月13日	v.1.1	3～5	新TABLEAUへの切り替えのため、新TABLEAUに合わせた画像および説明文を説明文を変更。
2023年11月13日	v.1.2	6,7,13	評価項目追加(Qタイム)のため画像を変更。
2023年11月13日	v.2	8,11	評価項目追加(Qタイム)のため、説明文を追加。
2024年5月14日	v.3		
2024年3月31日	v.4	11	1勝の定義閾値変更による
2025年5月23日	v.5		図の最新化、単位を%に統一

1. Garoonの業務アプリ一覧からログインする方法

SOMPOケア

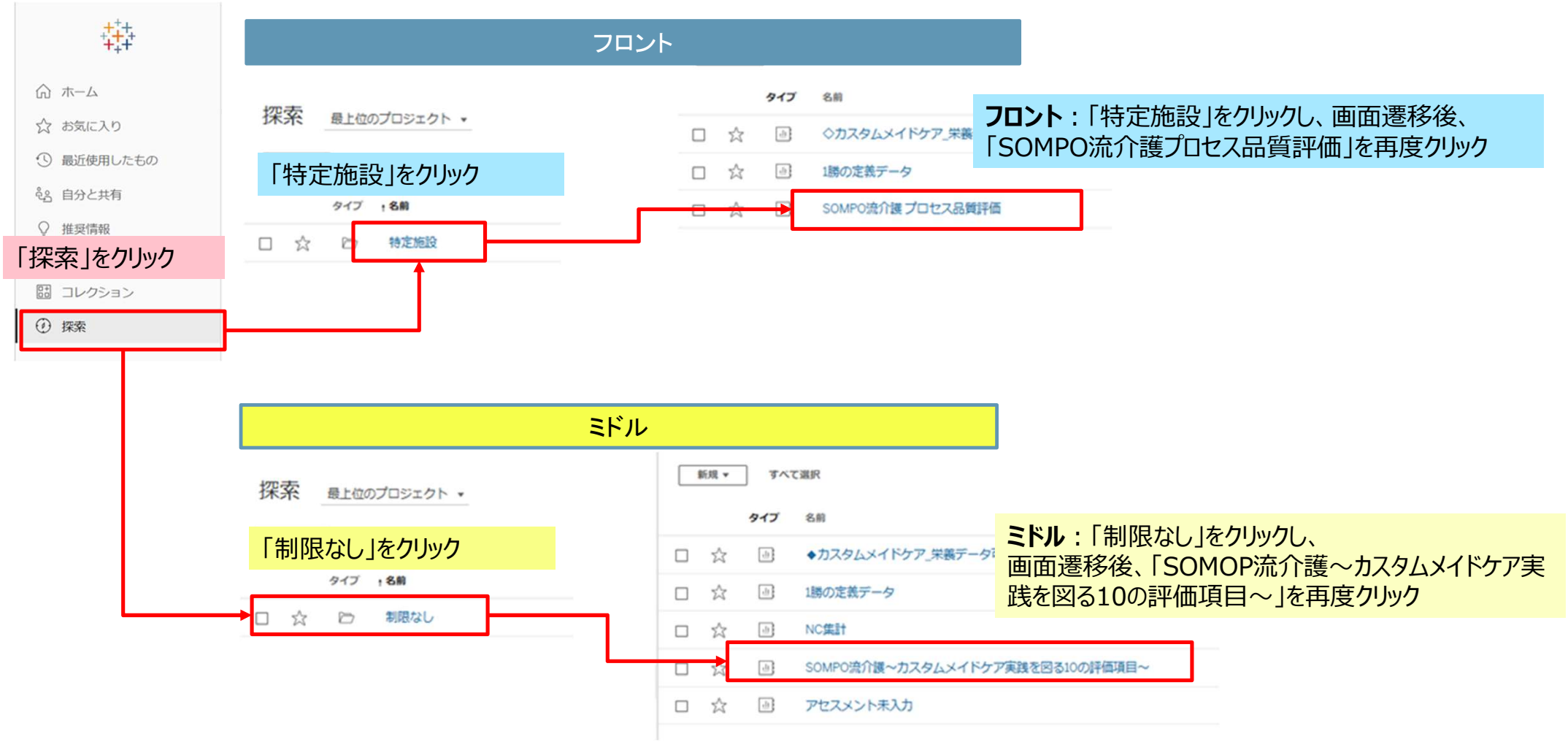
① ガルーンの「業務アプリ一覧」のタブより「新TABLEAU」を選択

② 「ユーザー名」と「パスワード」を入力して「サインイン」をクリック

アカウント情報が不明な場合は セットアップコールセンターへ連絡ください

1. ログインから確認用画面までの画面遷移①

SOMPOケア



1. ログインから確認用画面までの画面遷移②

SOMPOケア

④「ダッシュボード 全体 施設用」及び
「ダッシュボード 全体」ではそれぞれ以下を
確認することができる

ダッシュボード全体：
全施設の進捗状況を数値で一覧確認できる。
ミドル向け画面

ダッシュボード 全体 施設用：
施設ごとの個別の数値を確認できる。各数値の
評価指標の説明や詳細の内訳を確認できる

2.【 ダッシュボード全体施設用 】の見方①＿TOPページ

SOMPOケア

対象月、自ホーム名が表示されます

SOMPO流介護～カスタムメイドケア実践を図る10の評価項目～

Month 2025/04/01

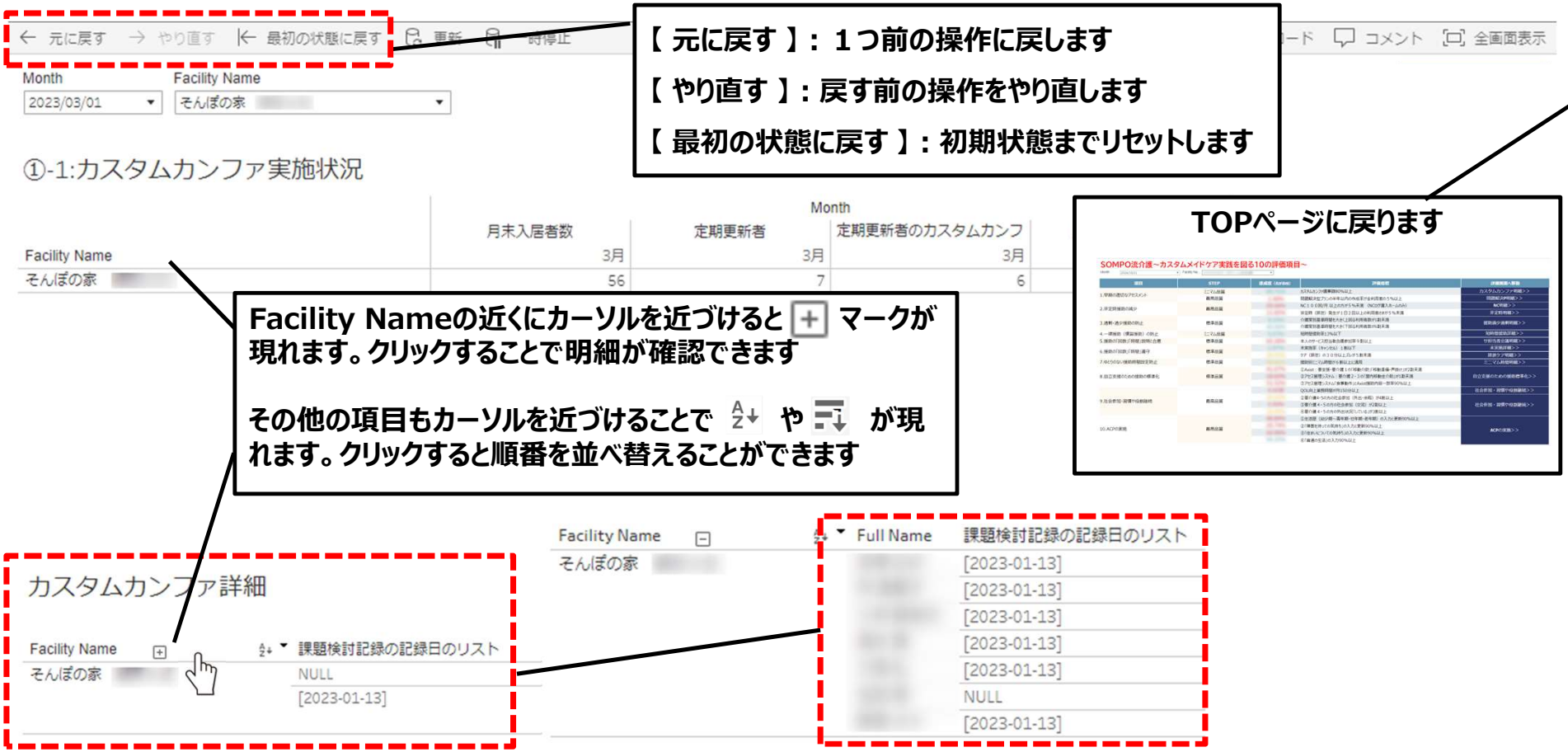
毎月の目標が達成されていれば青で表示

項目	STEP	達成度（青が合格）	評価指標	詳細画面へ移動
1.早期の適切なアセスメント	ミニマム品質	100.00%	カスタムカンファ議事録80%以上	カスタムカンファ明細＞＞
	最高品質	43.40%	問題解決型プランの半年以内の作成率が全利用者の５%以上	問題解決P明細＞＞
2.非定時援助の減少	最高品質	5.66%	NC１００回/月 以上の方が５%未満 （NCログ導入ホームのみ）	NC明細＞＞
		0.00%	非定時（排泄）発生が１日２回以上の利用者さまが５%未満	非定時明細＞＞
3.過剰・過少援助の防止	標準品質	3.77%	介護度別基準時間を大きく上回る利用者数が10%未満	援助過少過剰明細＞＞
		33.96%	介護度別基準時間を大きく下回る利用者数が60%割未満	
4.一律援助（慣習援助）の防止	ミニマム品質	7.56%	短時間援助率13%以下	短時間援助詳細＞＞
5.援助の「回数」「時間」説明と合意	標準品質	100.00%	本人のサービス担当者会議参加率90%以上	サ担当者会議明細＞＞
6.援助の「回数」「時間」遵守	標準品質	3.12%	未実施率（キャンセル）5%未満	未実施詳細＞＞
		13.63%	ケア（排泄）の30分以上ズレが20%未満	排泄ケア明細＞＞
7.ゆとりのない援助時間設定防止	標準品質	56.94%	援助別ミニマム時間が60%以上に適用	ミニマム時間明細＞＞
8.自立支援のための援助の標準化	標準品質	43.48%	1)Axist：要支援・要介護１の「移動介助」「移動準備・声掛け」が20%未満	自立支援のための援助標準化＞＞
		0.00%	2)アセス管理システム：要介護２・３の「屋内移動全介助」が10%未満	
		87.50%	3)アセス管理システム「食事動作」とAxist援助内容一致率90%以上	
9.社会参加・習慣や役割継続	最高品質	138.94分	QOL向上業務時間が月150分以上	社会参加・習慣や役割継続＞＞
		10.00%	1)要介護4・5の方の社会参加（外出・余暇）が40%以上	社会参加・習慣や役割継続＞＞
		10.00%	2)要介護４・５の方の社会参加（交流）が20%以上	
		0.00%	3)要介護４・５の方の外出状況「している」が30%以上	
10.ACPの実施	最高品質	86.79%	1)生活	ACPの実施＞＞
		22.64%	2)「障	
		24.53%	3)「住ま	
		50.94%	4)「普通の生活」の入力90%以上	

詳細ページへ移動します

2.【 ダッシュボード全体施設用 】の見方②＿詳細ページ

SOMPOケア



【 元に戻す 】：１つ前の操作に戻します

【 やり直す 】：戻す前の操作をやり直します

【 最初の状態に戻す 】：初期状態までリセットします

Facility Nameの近くにカーソルを近づけると ＋ マークが現れます。クリックすることで明細が確認できます

その他の項目もカーソルを近づけることで A↓Z や ≡↓ が現れます。クリックすると順番を並べ替えることができます

TOPページに戻ります

Topページ
カスタムカンファ明細
問題解決P明細
NC明細
非定時明細
援助過少過剰明細
短時間援助明細
サ担当者会議明細
未実施詳細
排泄ケア明細
ミニマム時間明細
Qタイム
ケアプラン評価

各項目詳細画面へ移動します

並べ替え時の留意点について

≡↓ で並べかえる場合：クリックごとに「降順」→「昇順」→「初期状態」の順番で並び替わります

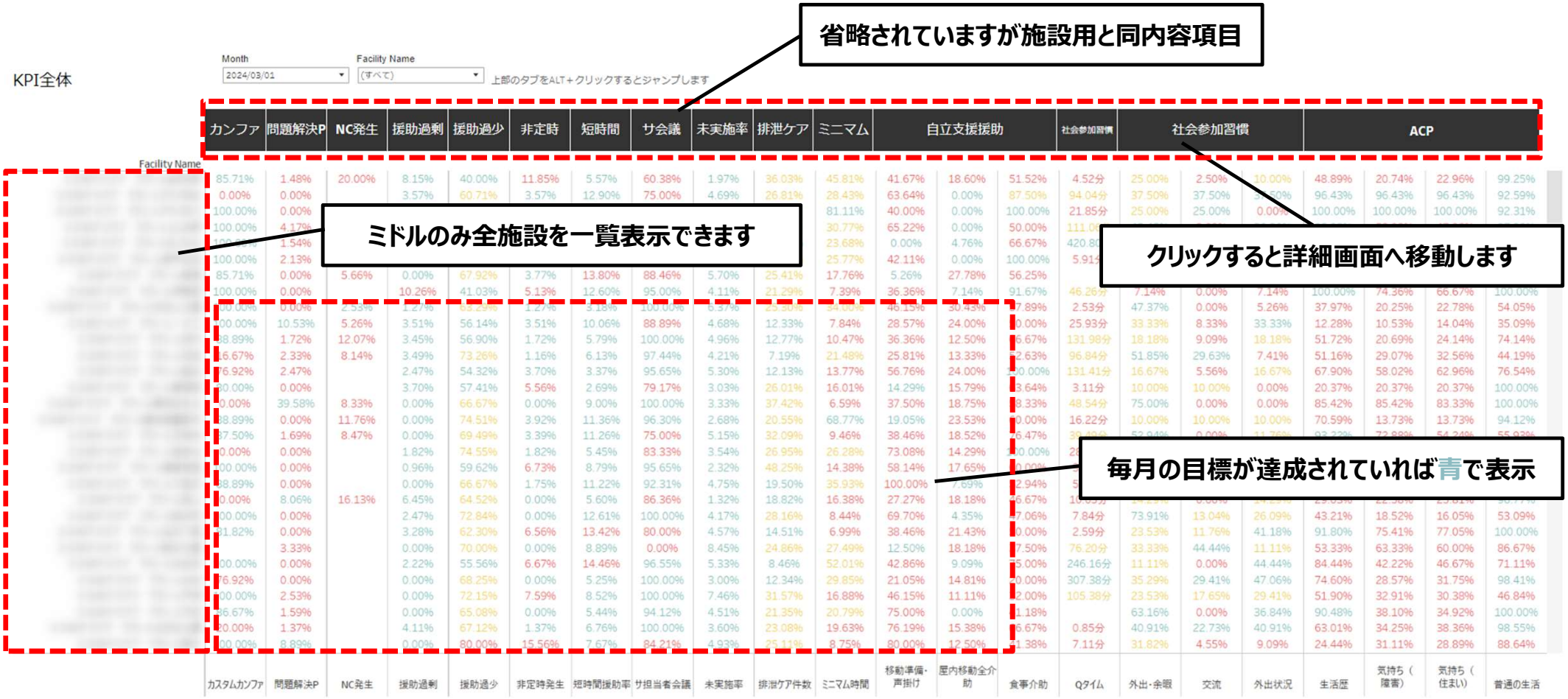
A↓Z で並べかえる場合：「昇順」→「降順」→「初期状態」の順ですが「あいうえお順」ではなく「アルファベット順」

2.【 ダッシュボード全体施設用 】の見方③＿各指標の説明

項目	STEP	評価指標	目的	算定式…詳細は次ページ
1.早期の適切なアセスメント	ミニマム	カスタムカンファ議事録80%以上	問題解決における取り組みの標準化	「課題などの検討記録」の数／更新者数
	最高	問題解決型プランの半年以内の作成率が全利用者の5%以上		「問題解決型プラン」の数／月末利用者数
2.非定時援助の減少	最高	NC100回/月 以上の方が5%未満（NCログ導入ホームのみ）		NC100回以上の対象者数／月末利用者数
		非定時（排泄）発生が1日2回以上の利用者様が5%未満		直近1か月間で日次平均２回以上の非定時（排泄）対応をした対象者数／月末利用者数
3.過剰・過少援助の防止	標準	介護度別基準時間を大きく上回る利用者数が10%未満	援助の適正化	「援助過剰」対象者数／月末利用者数
		介護度別基準時間を大きく下回る利用者数が60%未満		「援助過少」対象者数／月末利用者数
4.一律援助（慣習援助）の防止	ミニマム	短時間援助13%以下		5分以下のセット化されてない短時間の援助予定回数／総援助予定回数
5.援助の「回数」「時間」説明と合意	標準	本人のサービス担当者会議参加率90%以上		直近2か月間のサービス担当者会議における「本人」が「出席」の数／直近2か月間での会議数
6.援助の「回数」「時間」厳守	標準	未実施率（キャンセル）5%未満	ケアの標準化	未実施ケアの総回数／総援助予定回数
		ケア（排泄）の30分以上ズレが20%未満		排泄予定から30分以上ずれた総援助回数／ 排泄の総援助予定回数
7.ゆとりのない援助時間設定防止	標準	援助別ミニマム時間が60%以上に適用		ミニマム時間以上に設定された援助予定回数／ミニマム時間を定義したケアの総予定回数
8.自立支援のための援助の標準化	標準	1)Axist：要支援・要介護１の「移動介助」「移動準備・声掛け」が20%未満 2)アセス管理システム：要介護２・３の「屋内移動全介助」が10%未満 3)アセス管理システム「食事動作」が自立以外＋Axist「食事介助」「食事見守り」の利用者一致率90%		1)Axist「移動介助」「移動準備」声掛けが1回以上入っている人の人数/要支援・要介護1の人数 2)アセス管理システム「屋内移動全介助」の人数/要介護2・3の人数 3)Axist「食事介助」「食事見守り」「経管栄養」/アセス管理システム「食事動作」が自立・非実施以外の人数
9.社会参加・習慣や役割継続	最高	1)Qタイム＋趣味習慣参加援助予定が1人当たり月150分以上 2)要介護4・5の方の社会参加（外出・余暇）が③以上の方が40%以上 3)要介護4・5の方の社会参加（交流）が③以上の方が20%以上 4)要介護4・5の方の外出状況「している」が30%以上	参加実現の標準化	1)1ヶ月のQタイム項目の合計時間＋個別参加援助合計/月末利用者数 2)3)4)アセス管理システム該当項目人数/要介護4・5の月末利用者数
10.ACPの実施	最高	1)生活歴（幼少期～青年期・壮年期・老年期）入力率　90%以上かつ更新有 2)「障害を持っての気持ち」入力率　90%以上かつ更新有 3)「住まいについての気持ち」入力率　90%以上かつ更新有 4)「普通の生活」の入力率　90%以上		1)2)3)4)アセス管理システム該当項目人数/月末利用者

3.【 ダッシュボード 全体 】の見方

SOMPOケア



指標詳細

項目	1.早期の適切なアセスメント		2.非定時援助の減少	
評価指標	カスタムカンファ議事録80%以上 ※P未確定,アセスv3も集計に含む	問題解決型プランの半年以内の作成率が全利用者の5%以上	NC100回/月 以上の方が5%未満 （NCログ導入ホームのみ）	非定時（排泄）発生が１日２回以上の利用者様が5%未満
分子詳細	**「課題などの検討記録」の数：** カスタムカンファの「記録日」と「評価日」が更新日より遡って90日以内に作成されている利用者数	**「問題解決型プラン」の数：** 当月より遡って6か月間、「記録日」が存在する利用者数 ※4月分の場合は10月～3月が対象期間	**NC100回以上の対象者数：** １か月間（１日～末日）でナースコールを100回以上押した対象者の数	**直近1か月間で日次平均２回以上の非定時（排泄）対応をした対象者数：** 日割り計算でケア項目「排泄」を対象に１日平均２回以上の非定時対応を要した利用者数
分母詳細	**更新者数：** 短期目標開始日が当月1日かつ ケアプラン１表の区分が“継続”の利用者数 ※4月分の場合は4月1日開始プランが対象	**月末利用者数：** 前月末日の利用者数 ※4月分の場合は3月末日が対象期間	**月末利用者数：** 前月末日の利用者数 ※4月分の場合は3月末日が対象期間	**月末利用者数：** 前月末日の利用者数 ※4月分の場合は3月末日が対象期間
対策案	●カスタムカンファ対象者が適切に選択されているか確認しましょう。 ●問題解決型プランで議事録作成している場合はカウントされません。 ●カンファを円滑に進めるための、事前議事録、カンファ中の作成を推奨します。 ●ケアプランにつなげるために、また各職種で内容共有できるように議事録は重要です。 ●エクセルやワード等紙ではなくデータとして保管できるシステム管理へ移行しましょう。	●転倒、失禁、食事低下、BPSD等の方に対し、問題解決型プランを作る習慣を作りましょう。 ●まずは「問題点」に内容を記載しましょう。（ご本人にとっての困りごと視点が大切） ●「状態の記述」にはなるべく客観的な指標（回数、時間、量など）を使ってみましょう ●「分析」は考えられる「原因」記載してみましょう。ケアマネ・ケアスタッフ・そして看護師からの意見も重要です。 ●「対策」は期間と役割を記載してみましょう。 ※記載したものは事業所内で共有して活用。	●45回以上の方については、増加してくる可能性があるため、早めに取り組みましょう。早めの場合は主訴もわかりやすく対策も講じやすいです。 ●ホーム側でコールを生み出し、発生させていないか、慣習を確認してみましょう。 ●難易度が高いケースは、不適切ケア予防のためにも、本社ケア相談支援課や業務支援部への相談を検討しましょう。	●記録を正しく入力しましょう。いつから増えたのか、何時が多いのかなど、egakuでの分析が可能となります。 ●援助時間、援助方法が適切か見直しましょう。 ●排便管理の方法が適切か見直しましょう。
動画マニュアル案内	●ファイル管理＞ミドル＞未来の介護推進部＞虎の巻・ルールブック関連＞虎の巻下巻「カスタムカンファ開催」	●ファイル管理＞ミドル＞未来の介護推進部＞虎の巻・ルールブック関連＞虎の巻下巻「PROMに沿ったアセスメント」 ●ABILIClip＞クリップ＞カスタムメイドケア（未来の介護）の理解と実践＞やってますか？アセスメント20＞尿失禁のアセスメント、食事量低下のアセスメント、転倒のアセスメント、認知障がいのアセスメント等	●ファイル管理＞ミドル＞未来の介護推進部＞「非定時ケア見直しルールブック」 ●ABILIClip＞クリップ＞カスタムメイドケア（未来の介護）の理解と実践＞「非定時ケア見直しルールブック」	●ファイル管理＞ミドル＞未来の介護推進部＞虎の巻・ルールブック関連＞虎の巻下巻「転倒・失禁・嚥下のアセスメント」 ●ABILIClip＞クリップ＞カスタムメイドケア（未来の介護）の理解と実践＞やってますか？アセスメント20＞尿失禁のアセスメント・排便のアセスメント

項目	3.過剰・過少援助の防止		4.一律援助（慣習援助）の防止	5.援助の「回数」「時間」説明と合意
評価指標	介護度別基準時間を大きく上回る利用者数が10%未満	介護度別基準時間を大きく下回る利用者数が60%未満	短時間援助13%以下	本人のサービス担当者会議参加率90%以上 ※P未確定も集計
分子詳細	**「援助過剰」対象者：** 援助予定時間が一つ上の介護度の基準時間を超過している利用者数 ※境界値を含まない	**「援助過少」対象者：** 援助予定時間が一つ下の介護度の基準時間を下回る利用者数 ※境界値を含まない	**5分以下のセット化されていない短時間の援助予定回数：** 5分以下の短時間援助であり、他援助とのセット化がなされていない援助予定 ※除外…移動介助・体位変換・排泄介助・トイレ介助・オムツ交換・Pトイレ介助・薬介助・点眼・施設業務	**直近2か月間のサービス担当者会議における「本人」が「出席」の数：** 分母と同条件の会議の内、アセスｖ４の“出欠”より“本人”が“出席”である会議数
分母詳細	**月末利用者数：** 前月末日の利用者数 ※4月分の場合は3月末日が対象期間		**総援助予定回数：** 利用者に紐づかない施設業務は除く 援助予定回数の総数	**直近２か月間での会議数：** ①短期目標開始日が毎月1日のみ ②“開催日”が当月及び前月 ③会議種別が“サービス担当者会議” ④会議開催数が複数ある場合は全てカウント ※①～④を全て満たす会議件数
対策案	●援助過剰の場合は「区分変更」か「援助内容・回数・方法の見直し」を実施しましょう。 ●援助過少の場合は「非定時ケア」「回数・時間の不足」「自立支援の為の時間確保」を評価しましょう。 ●Axist入力方法の問題がないか（個別援助をホーム業務にしている、又はその逆）見直しましょう。 ※10%・60%等の指標はアラートであり、個別の対応が必要。		●tableau「カスタムメイドケア実践を図る10の評価項目」の「短時間援助詳細」にてどのご利用者さまが多いのかを確認しましょう。 ●「ご自分で行える工夫」「他の援助とセット」を検討しましょう。 ※全体的に多い場合はホームの慣習が残っているケースが多い。	●サ担開催日をケアマネジャー中心に更新月にスケジューリングしましょう。 ●日程をご利用者さま・ご家族さまへ連絡しましょう。 ●ご利用者さま・ご家族さまとも担当者会議ではご意見を伺い、記録に残すようにしましょう。 ※介護保険サービス事業者として、顧客であるご利用者さま本人には、障がいの程度に関わらず原則参加していただくのは当たり前と認識すること。
動画マニュアル案内	●ファイル管理＞ミドル＞未来の介護推進部＞虎の巻・ルールブック関連＞虎の巻下巻「ご本人さまの能力を考慮したケアプラン」 ●ファイル管理＞ミドル＞教育研修＞ケアマネジメント・計画作成関連＞基準プラン＞「基準プラン入門テキスト」		●ファイル管理＞ミドル＞未来の介護推進部＞「一律援助見直しルールブック」「慣習援助見直しルールブック」 ●ファイル管理＞ミドル＞教育研修＞ケアマネジメント・計画作成関連＞基準プラン＞「基準プラン入門テキスト」	●ファイル管理＞ミドル＞未来の介護推進部＞虎の巻・ルールブック関連＞虎の巻下巻「利用者さまの高いQOL・希望に近い援助」

項目	6.援助の「回数」「時間」厳守		7.ゆとりのない援助時間設定防止
評価指標	未実施率（キャンセル）5%未満	ケア（排泄）の30分以上ズレが20%未満	援助別ミニマム時間が60%以上に適用
分子詳細	**未実施ケアの総回数：** ホーム全体の未実施ケアの総回数 ※全てのケア項目 ※利用者と紐づかない施設業務は除外 ※未実施ケアは“その他中止”、“不在中止”、“空振り（拒否）”、“体調不良/中止”含む	**排泄予定から30分以上ずれた総援助回数：** ケア項目“排泄”の援助予定の内、予定時刻から30分以上のズレが発生した回数	**ミニマム時間以上に設定された援助予定回数：** 対象となるケア項目において、それぞれ右表に定めるミニマム時間以上の時間で設定された援助予定回数
分母詳細	**総援助予定回数：** ホーム全体の援助予定の総回数 ※全てのケア項目 ※利用者と紐づかない施設業務は除外	**排泄の総援助予定回数：** ケア項目“排泄”の総援助予定回数	**ミニマム時間を定義したケアの総予定回数：** “オムツ交換”、“トイレ介助”、”着脱介助”、“口腔ケア介助”、“食事介助”、“入浴介助”の援助予定回数
対策案	●未実施の理由が 「自分でできている」 「援助を断られる（受けたくない）」 「時間や内容が合っていない」 のどれに当てはまるのか評価しましょう。 ●「援助中止し自立」「時間・方法見直し」等工夫をして未実施を減らしていきましょう。 ●未実施が多い＝ケアプランに同意が得られていないこととなりますので、ケアプランを軸にご利用者さまと話し合いましょう。 ※新入居、退院直後など手厚めに援助が入っている時期は一時的に多くても問題はない。	●tableau「カスタムメイドケア実践を図る10の評価項目」の「排泄ケア明細」にてどのご利用者さまが多いのかを確認しましょう。 ●「タップ遅れ」が理由の場合、速やかな記録の重要性を周知しましょう。 ●アクシストと現場の乖離があれば、アクシストを速やかに変更しましょう。 ●援助のお断りなどある場合は、ご利用者さま・ご家族さまとケアプランを中心に話し合ってください。 ※多少の援助のズレはやむを得ませんが、サービス事業者として、時間はケアプランでご利用者さまと約束したものであることを認識しておきましょう。	●tableau「カスタムメイドケア実践を図る10の評価項目」の「ミニマム時間明細」にてどのご利用者さまが設定値が低いのかを確認しましょう。 ●「着脱介助1分」「トイレ介助2分」など明らかに適切ではない可能性の高いものは、時間の修正を行ってください。 ※全ての時間帯で、全てのご利用者さまに、この時間を確保しなければならないものではありません。 しかし、Axistはケアプランの反映＋業務管理ソフトです 援助を詰め込まず、説明や記録に時間をあててもらい、ケアスタッフに無理をさせないことは、接遇やホスピタリティの視点からも大切です。
動画マニュアル案内	●ファイル管理＞ミドル＞未来の介護推進部＞カスタムメイドケア・egaku関連＞カスタムメイドケア実践ガイドライン介護付きホーム版 ●ファイル管理＞ミドル＞未来の介護推進部＞虎の巻・ルールブック関連＞虎の巻下巻「ご本人さまの能力を考慮したケアプラン」「ケアプランと個別サービスの連動」「利用者様の高いQOL・希望に近い援助」「スタッフの充実感」		

参照： ミニマム時間とは

品質保持を目的として最低限確保したい各ケア項目ごとの援助時間をミニマム時間と定義し、以下に定めるものとする

※数値根拠は実証事業12ホームの取組後の平均分数に2分プラスしています。「人間尊重」の考え方から、この6つの援助については能力向上、コミュニケーション、記録のためゆとりのある援助時間を推奨します。

オムツ交換	６分	口腔ケア介助	５分
トイレ介助	６分	食事介助	１８分
着脱介助	５分	入浴介助	３０分

項目	8.自立支援のための援助の標準化		
評価指標	１）Axist：要支援･要介護1の｢移動介助｣･｢移動準備･声掛け｣が20%未満	２）アセスメント管理システム：要介護2･3の｢屋内移動全介助｣が10%未満	３）アセスメント管理システム：｢食事動作｣とAxist援助内容一致率90%以上
分子	**Axist｢移動介助｣｢移動準備･声掛け｣人数** ※要支援１･要支援２･要介護１のみ　※月毎	**アセスメント管理システム｢屋内移動：全介助｣人数** ※要介護２･要介護３のみ　※月毎	**Axist｢食事介助｣｢食事見守り｣｢経管栄養（滴下･注入）｣人数**
分母	**要支援１･要支援２･要介護１の総人数** 前月末日の利用者数 ※4月分の場合は3月末日が対象期間	**要介護２･要介護３の総人数** 前月末日の利用者数 ※4月分の場合は3月末日が対象期間	**アセスメント管理システム｢食事動作-している活動｣が｢見守り｣｢一部介助｣｢全介助｣の総人数** 前月末日の利用者数 ※4月分の場合は3月末日が対象期間
対策案	●要支援･要介護1の場合、心身機能としては｢移動自立｣を目指すことができると考えられます。 ｢原因除去｣｢環境整備･補助具｣を工夫し、自立を目指すプランに変更しましょう。 ●ご利用者さま本人のご希望がある場合は、なぜ希望されるのか、どのような真のニーズがあるのか、チームで検討してみましょう。	●心身機能としては、｢全介助｣ではなくご自身の残存能力を使い、能力向上を目指すことができると考えられます。 ｢原因除去｣｢換気用整備･補助具｣を工夫し、｢見守り｣｢一部介助｣｢自立｣を目指しましょう。 ●リスク重視による尊厳の低下が起こっていないか（危ないから車いすにするなど）チェックし、見直してください。 ●介護者都合による援助になっていないか（時間がないからzん介助など）チェックし、見直してください。	●アセスメント･プランが正しく更新されているか確認してください。 ●アセスメント上、食事動作に援助が必要と判断された場合はまずは自立できる方法を工夫してください。 ●それでも必要と判断された場合は援助を位置づけてください。 ●｢見守り｣の定義は｢危険な時などとっさに手出しができる｣距離で見守ることを意味します。（以下【教育】ケアプラン･サービス計画作成の手引き～能力評価編～｣より抜粋） ●3か月連続で不一致が見られるご利用者さまは黄色でアラート表記しています。
動画マニュアル案内	●ファイル管理＞ミドル＞教育研修部＞ケアマネジメント･計画作成関連＞ケアプラン･サービス計画作成の手引き＞｢やってますか？アセスメント20｣＞｢自立支援へのアセスメント｣ ●ABILIClip＞クリップ＞やってますか？アセスメント20＞自立支援へのアセスメント	●ファイル管理＞ミドル＞教育研修部＞ケアマネジメント･計画作成関連＞ケアプラン･サービス計画作成の手引き＞｢やってますか？アセスメント20｣＞｢自立支援へのアセスメント｣ ●ABILIClip＞クリップ＞やってますか？アセスメント20＞自立支援へのアセスメント	

自立(独立)	･介護者が全く不要でひとりで可能。 ･補助具の使用の有無や安全･疲労に対する自己管理(自身で休憩をとりながら行なう等)をしている場合も含む。
見守り	･介護者が必要だが、声かけや説明があれば直接手出しをしなくても可能。 ･常に手出しは不要だが、危険な時など、とっさの時は手出しが必要なときもある。(そのように準備しておく必要がある場合)
一部介助	･動作及び関連する諸動作(道具の準備など)において介護者の部分的な介助(該当する動作において、おおむね半分以下の介助量)があればできる場合。 ･準備のみの場合や手直し、体の一部を支える、作業の一部を手伝うなど程度の軽～中等度のもの。
全介助	･動作に多くの介助(該当する動作において、おおむね半分を超える介助量)がないとできない。 ･常に介護者の多くの援助が必要な場合や持ち上げる、作業の多くを手伝うなど中等度を超え重度～全ての介助を要する場合。
非実施	･行っていない場合や行えない場合

項目	9.社会参加・習慣や役割継続			
評価指標	１）QOL向上業務時間が月150分以上(利用者一人あたり)	２）要介護4・5の方の社会参加（外出・余暇）が40%以上	３）要介護4・5の方の社会参加（交流）が20%以上	４）要介護4・5の方の外出状況「している」が30%以上
分子	**ホームごとのQタイム項目の合計時間＋個別参加援助の合計時間**	**アセスメント管理システム「日頃の外出・余暇」実施人数** ※③④⑤は下記参照	**アセスメント管理システム「日頃の他者との交流・社会参加」実施人数** ※③④⑤は下記参照	**アセスメント管理システム「外泊・外出・旅行-外出-」を「している」人数**
分母	**月末利用者数** 前月末日の利用者数 ※4月分の場合は3月末日が対象期間	**「月末利用者」かつ直近アセス「要介護4・5」の月毎の人数** 前月末日の利用者数 ※4月分の場合は3月末日が対象期間		
対策案	●ご利用者さまのご意見を聴取し、Qタイムに位置付ける個別参加援助やQタイム業務を明確にしましょう。 ※QOLの向上に資する「個別の習慣・参加」「コミュニケーション」などの実施を目的に、ケアプラン（３表）への位置づけを進めることが望ましい。 ●カスタムメイドケアの推進によるケアの見直し、施設業務等の定期的な点検やテクノロジーの導入により、業務の「ムリ・ムダ・ムラ」を見直し、Qタイムの確保に努めましょう。 ●アクティビティ業務の入力ルールについては「Axist入力ルールブックテキスト」を参照ください。	●アセスメントが正しく更新されているか確認してください。 ●要介護度に関わらず、外出や余暇は大切です。インフォーマル、プライベートサービスを活用して機会を提案しましょう。 **※アセスメント管理システムより** **【日ごろの外出・余暇の状況】** ⑤　施設や家を１日以上離れる外出、または 旅行を行っている ④　⑤のような旅行はしていないが、屋外で行うような趣味活動を行っている ③　④のような屋外ではなく屋内で行うよ うな集団での活動、レクリエーション等を行っている ②　③④のような活動はしていないが、施設や家でひとりでテレビを楽しむ等のことはしている ①　テレビやラジオを楽しむことをしていない、できない	●アセスメントが正しく更新されているか確認してください。 ●要介護度に関わらず、他者との交流は大切です。様々な角度から機会を提案しましょう。 **※アセスメント管理システムより** **【日ごろの他者との交流・社会参加】** ⑤　電話・手紙・メール・ＳＮＳなど情報伝達手段も用いて自ら交流を行っている ④　⑤のような情報手段は行っていないが、親族、知人を訪ねる目的で外出している ③　外出はしていないが、家族だけではなく、家族以外の親族、友人・知人の訪問も受け、会話をしている ②　職員、同じ施設の入所者や、家族との会話をしている ①　会話などをしていない。できない	●アセスメントが正しく更新されているか確認してください。 ●ケアプラン有効期間内（概ね半年以内）に1度も外出していない場合、カスタムメイドケアの観点から個別に見直してみましょう。
動画マニュアル案内	●ファイル管理＞ミドル＞未来の介護推進部＞虎の巻・ルールブック関連＞Qライン稼働・Qタイム実施ルールブック ●ファイル管理＞ミドル＞システムマニュアル＞ケアマネジメントシステム＞Axist＞「Axist運用マニュアル別冊：Axist入力ルールブックテキスト」	●ファイル管理＞ミドル＞教育研修部＞ケアマネジメント・計画作成関連＞ケアプラン・サービス計画作成の手引き＞「やってますか？アセスメント20」＞「参加（楽しみ・生きがい）へのアセスメント」 ●ABILIClip＞クリップ＞やってますか？アセスメント20＞参加へ（楽しみ・生きがい）のアセスメント		

項目	10.ACPの実施			
評価指標	１）生活歴（幼少期～青年期・壮年期・老年期）の入力と更新90%以上	２）「障害を持っての気持ち」の入力と更新90%以上	３）「住まいについての気持ち」の入力と更新90%以上	４）「普通の生活」の入力率90%以上
分子	**「生活歴」入力＋更新有人数** 直近のアセスメント管理システム 「生活歴」より 「幼少期～青年期」「壮年期」「老年期」が ・空白でない かつ ・直近アセス12か月前～6か月前のアセスと比較し、「老年期」から文字数が変化している月毎の人数 ※過去アセスが12か月前～6か月前に存在しない場合は新規とみなして分子は「あり」と判断	**「障害を持っての気持ち」入力＋更新有人数** 直近のアセスメント管理システム 「生活歴・参加等（気持ち・主訴等）」より「障害を持っての気持ち」が ・空白でない かつ ・直近アセス12か月前～6か月前のアセスと比較し、「障害を持っての気持ち」から文字数が変化している月毎の人数 ※過去アセスが12か月前～6か月前に存在しない場合は新規とみなして分子は「あり」と判断	**「住まい・住まい方・転居についての気持ち」入力＋更新有人数** 直近のアセスメント管理システム 「生活歴・参加等（気持ち・主訴等）」より 「住まい・住まい方・転居についての気持ち」が ・空白でない かつ ・直近アセス12か月前～6か月前のアセスと比較し、「住まい・住まい方・転居についての気持ち」から文字数が変化している月毎の人数 ※過去アセスが12か月前～6か月前に存在しない場合は新規とみなして分子は「あり」と判断	**「普通の生活」入力有人数** 直近のアセスメント管理システム 「生活歴・参加等（普通の生活）」より 「家事の習慣「身だしなみ」」「外泊・外出・旅行」 「買い物」「地域との関わり」 「家族や友人との関わり」 「公的契約や金銭管理など」「趣味」 「信条や信仰」「食事の好みや習慣」 「機器の利用や管理」 の11項目に入力がある月毎の人数
分母	**月末利用者数** 前月末日の利用者数 ※4月分の場合は3月末日が対象期間			
対策案	●生活歴を知ること＝カスタムメイドケアの実践でありACPへ繋がります。入居面談で聞けなくても更新時に追加していきましょう ●老年期においては特に「障がいを持ってからの経過」「入居に至る経緯」が重要です。	●記載だけではなく更新も重要です。 ●「思い」は日々変化します。もし自分がご利用者ご本人だとしたら？今の障がいについてどのように思っているか？言葉だけではなく推察を行い更新しましょう。	●記載だけではなく更新も重要です。 ●「思い」は日々変化します。もし自分がご利用者ご本人だとしたら？今の障がいについてどのように思っているか？言葉だけではなく推察を行い更新しましょう。	●障がいをもつ直前の生活がどのようなものだったのか、11項目について入居面談で全て聞けなくても更新時に追加していきましょう。 ●「夢結いのーと」作成と合わせて、聞き取り内容をアセスメントにきちんと残していきましょう。
動画マニュアル案内	●ファイル管理＞ミドル＞未来の介護推進部＞虎の巻・ルールブック関連＞虎の巻下巻「生活歴の把握」	●ファイル管理＞ミドル＞未来の介護推進部＞虎の巻・ルールブック関連＞虎の巻下巻「心理面のアセスメント」	●ファイル管理＞ミドル＞未来の介護推進部＞虎の巻・ルールブック関連＞虎の巻下巻「心理面のアセスメント」	●ファイル管理＞ミドル＞未来の介護推進部＞虎の巻・ルールブック関連＞虎の巻下巻「普通の生活を知り能力と希望を把握」

SOMPO